

CAPÍTULO 8.21

Diarrea en Niños

PERFIL EUNACOM 1.06.1.027

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

# Reflujo, Dolor Abdominal y Constipación en Pediatría

1. Reflujo Gastroesofágico del Lactante

Fisiológico vs. Patológico

| TABLA 8.21.1: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS |                         |                                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|
|                                                  | REFLUJO FISIOLÓGICO     | REFLUJO PATOLÓGICO                      |
| Aspecto del lactante                             | Lactante feliz          | Malestar, irritabilidad                 |
| Incremento ponderal                              | Normal                  | Mal incremento (baja o no sube de peso) |
| Hemorragia digestiva                             | No                      | Posible                                 |
| Síntomas respiratorios                           | No                      | Sí (bronquitis obstructiva, asma)       |
| ALTE                                             | No                      | Posible (ahogamiento por aspiración)    |
| Conducta                                         | Educación, tranquilizar | Estudiar + tratar                       |

NOTA CLÍNICA

**Pico de regurgitación fisiológica:** 2–6 meses. Desaparece espontáneamente al año-año y medio. Frase clásica: "las únicas guaguas que no vomitan son las que no toman leche."

Diagnóstico

- Clínico para la mayoría
- pHmetría de 24 h si hay duda (igual que en adultos)

Tratamiento

- **Primera línea: Omeprazol (IBP)** — igual que en adultos
- - NO domperidona ni metoclopramida como primera línea (riesgo de síntomas extrapiramidales)
- **Segunda línea:** procinéticos (domperidona si IBP insuficiente)
- **Antihistamínicos H2** (ranitidina, famotidina): alternativa si alergia a IBP
- **Cirugía** (funduplicatura de Nissen): última línea, solo si reflujo patológico grave sin respuesta a tratamiento médico

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

**Domperidona y metoclopramida** = síntomas extrapiramidales (rigidez, tortícolis, trismus). No son primera línea. Si se usan → monitorear efectos adversos.

Diferencial: Estenosis Hipertrófica del Píloro

| TABLA 8.21.2: CLASIFICACIÓN Y CRITERIOS CLÍNICOS |                            |                                   |
|--------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|                                                  | RGE PATOLÓGICO             | ESTENOSIS HIPERTRÓFICA DEL PÍLORO |
| Inicio                                           | Desde nacimiento           | Semana 2–6 de vida                |
| Vómitos                                          | Regurgitaciones frecuentes | Vómitos explosivos, proyectivos   |
| Examen                                           | Normal                     | Oliva pilórica palpable a veces   |
| Diagnóstico                                      | Clínica / pHmetría         | Ecografía (píloro engrosado)      |
| Tratamiento                                      | IBP ± cirugía              | Piloro-tomía de Ramstedt          |

2. Dolor Abdominal Crónico en Pediatría

Con signos de alarma → Estudiar

- Signos de alarma que obligan a exámenes:
- Baja de peso
- Alteración del examen físico
- Vómitos o hemorragia digestiva
- Fiebre recurrente

→ ECO o TAC → tratar causa específica

Sin signos de alarma → Dolor Abdominal Psicógeno

- **Causa más frecuente** de dolor abdominal crónico en niños (no SII como en adultos)
- **Clues:**
  - - Aumenta con **estrés** (exámenes, inicio del año escolar)
  - - Disminuye en vacaciones o fin de semana
  - - Localización **periumbilical** (los niños señalan el ombligo al decir que les duele la guata)
- **Tratamiento:** tranquilizar, educar, manejo del estrés

PERLA CLÍNICA EUNACOM

**Niño que siempre duele los lunes antes del colegio y está bien los sábados → dolor psicógeno periumbilical.** Es la causa más frecuente, pero siempre hay que descartar organicidad.

3. Constipación y Fecaloma en Pediatría

Diagnóstico de Constipación

- ≤ 2 evacuaciones por semana
- Deposiciones duras, en bolita o muy voluminosas
- Dolor al defecar (por tamaño y dureza)
- Fecaloma (confirma constipación importante)

Círculo Vicioso

''' Constipación → Bolo fecal duro → Fisura anal → Dolor → Miedo a defecar → Constipación '''

Fecaloma — Clínica

- **Masa abdominal palpable** (causa más frecuente de masa abdominal en pediatría)
- **Pseudoincontinencia fecal** (rebalsamiento de feces líquidas alrededor del fecaloma)
- **Encopresis:** deposición involuntaria mientras duerme
- Manchado de calzoncillos (ensuciamiento constante)
- **Diagnóstico:** tacto rectal (se palpa la masa fecal dura en el recto)

EUNACOM CRITERIOS

**Consejo jurídico-médico:** Al realizar tacto rectal en niños → **siempre con testigo** (enfermera o auxiliar) y **dejar registro en ficha** con la firma del testigo. Protege al médico de acusaciones.

Manejo de la Constipación — 2 Fases en Orden

**Fase 1: Desimpactación** (primero sacar el fecaloma)

| TABLA 8.21.3: OPCIÓN VS DETALLE               |                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| OPCIÓN                                        | DETALLE                                                                      |
| PEG (Macrogol/Polietilenglicol) VO — Elección | Más eficaz; oral                                                             |
| Enema evacuante                               | Igualmente eficaz; alternativa si falla el PEG o como primera opción         |
| Si ambos fallan                               | <b>Proctocclisis</b> (irrigación rectal continua por sonda)                  |
| No recomendado                                | Desimpactación manual (doloroso, humillante, reservar solo excepcionalmente) |

**Fase 2: Mantenimiento** (evitar que se repita)

- **Laxantes al menos 4 semanas** (romper el círculo vicioso)
- **Hábito de defecación:** sentar al niño en el baño 5 min post-almuerzo diario
- Dieta rica en fibra + agua
- Educación sobre el proceso

**EUNACOM CRITERIOS**

**Orden obligatorio:** 1. Primero desimpactar (fase 1) 2. Luego mantener (fase 2)  
Si se salta la fase 1 y solo se dan laxantes → el fecaloma no sale → empeora.

**CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM**

**ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:**

"Lactante de 10 meses presenta cuadro de 2 días de vómitos y deposiciones líquidas abundantes (8 al día). Al examen: irritable, ojos hundidos, llanto sin lágrimas, boca muy seca, saliva filante, signo del pliegue cutáneo que desaparece lentamente (en 2 segundos) y sed intensa (bebe ávidamente la solución)."

**EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:**

Deshidratación Aguda Moderada por Gastroenteritis Aguda (Plan B de la OMS): manejo con Solución de Rehidratación Oral (SRO con osmolaridad reducida 245 mOsm/L) a 50-100 mL/kg en 4 horas fraccionado en pequeñas cucharaditas. Reevaluar al término de las 4 horas. Continuar lactancia materna en todo momento. No se indican antibióticos ni antieméticos de rutina.

**PUNTOS CLAVE DESTACADOS**

- La diarrea aguda pediátrica es mayoritariamente viral (rotavirus); el manejo fundamental es la hidratación según grado de deshidratación
- Plan A: oral post-deposición; Plan B: SRO 50-100 cc/kg en 4-6 h; Plan C: SF IV bolo 20 cc/kg
- Antidiarreicos contraindicados en pediatría; antibióticos solo ante Shigella o E. coli enteroinvasora
- La diarrea crónica inespecífica (por jugos hiperosmolares) es la causa más frecuente de diarrea crónica en niños
- Fibrosis quística: diarrea + neumonías (Pseudomonas/Staphylococcus); diagnóstico con test del sudor (cloro mayor o igual a 60 confirmado)
- Alergia a proteína de leche de vaca: diagnóstico con prueba terapéutica de 4 semanas con reintroducción
- Enfermedad celíaca: anticuerpos antitransglutaminasa + biopsia duodenal; tratamiento con dieta sin gluten

## EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (DIARREA EN NIÑOS)

## PREGUNTA 1

Lactante de 10 meses con diarrea acuosa de 3 días de evolución, llanto sin lágrimas, mucosas secas y baja de peso del 7%. ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

- A) Sales de rehidratación oral 50-100 cc/kg en 4-6 horas
- B) Suero fisiológico IV en bolo de 20 cc/kg
- C) Agua libre por vía oral a libre demanda
- D) Ciprofloxacino oral
- E) Loperamida para disminuir las deposiciones

## PREGUNTA 2

Preescolar de 4 años, procedente de zona rural, con diarrea crónica, flatulencia y dolor abdominal cólico. Otros miembros de la familia presentan síntomas similares. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A) Diarrea crónica inespecífica
- B) Enfermedad celíaca
- C) Giardiasis
- D) Fibrosis quística
- E) Alergia a la proteína de leche de vaca

## PREGUNTA 3

Lactante de 4 meses alimentado con fórmula presenta diarrea crónica, exantema cutáneo y episodios de sibilancias. ¿Cuál es el estudio diagnóstico más apropiado?

- A) Test del sudor
- B) Anticuerpos antitransglutaminasa
- C) Prueba terapéutica con fórmula hidrolizada por 4 semanas
- D) Parasitológico de deposiciones
- E) Endoscopia digestiva alta con biopsia

## RESUMEN: DIARREA EN NIÑOS

Clase sobre diarrea aguda y crónica en pediatría. La diarrea aguda es mayoritariamente viral (rotavirus es el más frecuente) y el manejo se centra en la hidratación según grado de deshidratación: Plan A (oral, 100-200 cc post deposición) para leve, Plan B (SRO 50-100 cc/kg en 4-6 horas) para moderada, y Plan C (suero fisiológico IV en bolo 20 cc/kg) para severa o shock. Se revisan las causas de diarrea crónica pediátrica: la diarrea crónica inespecífica (más frecuente, por jugos hiperosmolares), giardiasis (preescolares/escolares, zona rural), enfermedad celíaca (malabsorción con anticuerpos antitransglutaminasa), fibrosis quística (diarrea + neumonías por *Pseudomonas* o *Staphylococcus*) y alergia a la proteína de leche de vaca (lactantes con fórmula, síntomas GI + alérgicos, diagnóstico con prueba terapéutica de 4 semanas). Los antibióticos en diarrea aguda se indican solo ante sospecha de *Shigella* o *E. coli* enteroinvasora (mal estado general, fiebre alta, disentería). Los antidiarreicos están contraindicados en pediatría.